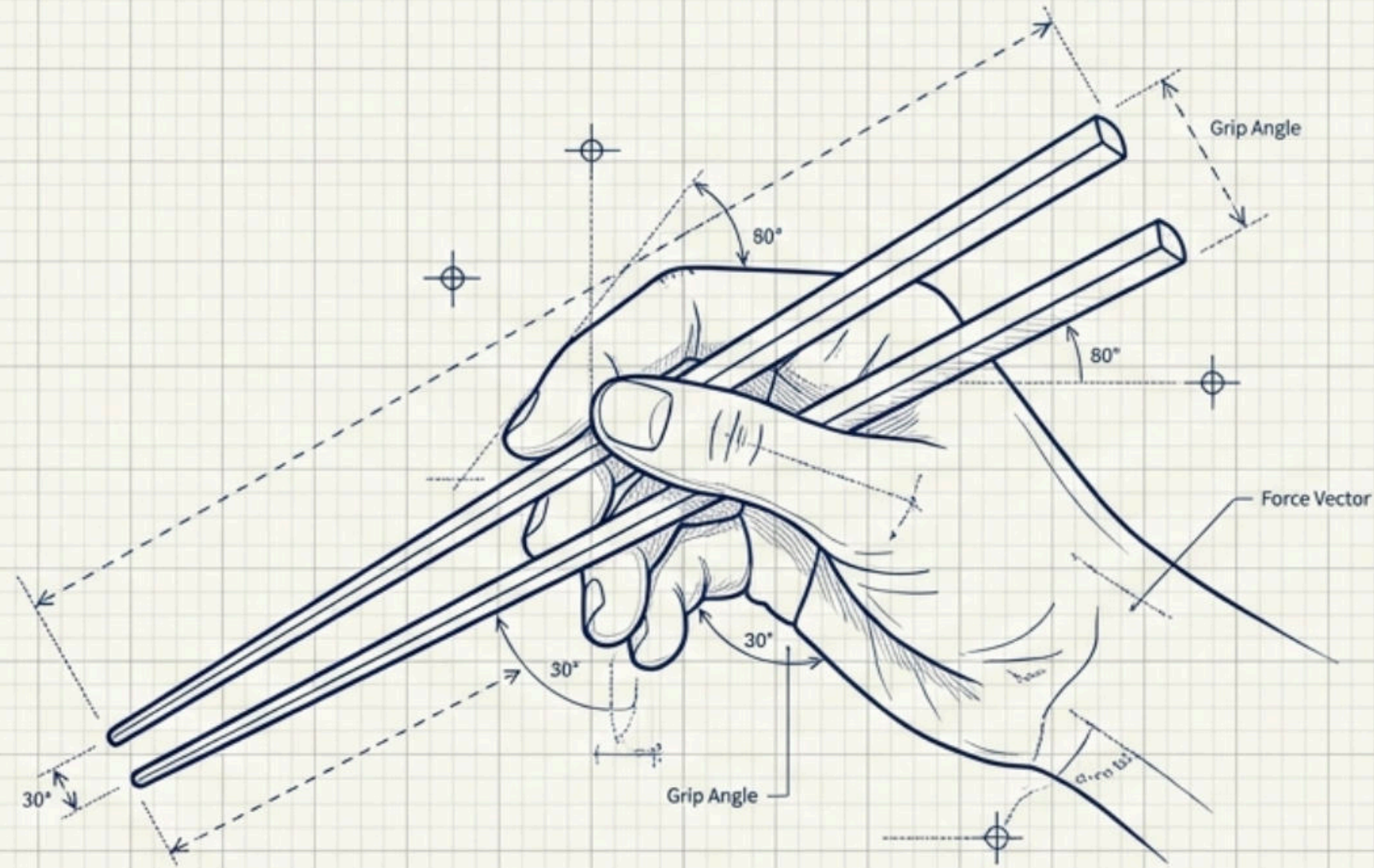




個性を伸ばす発達支援のデザイン

食事動作から学ぶ「自立」と「計画」の仕組み

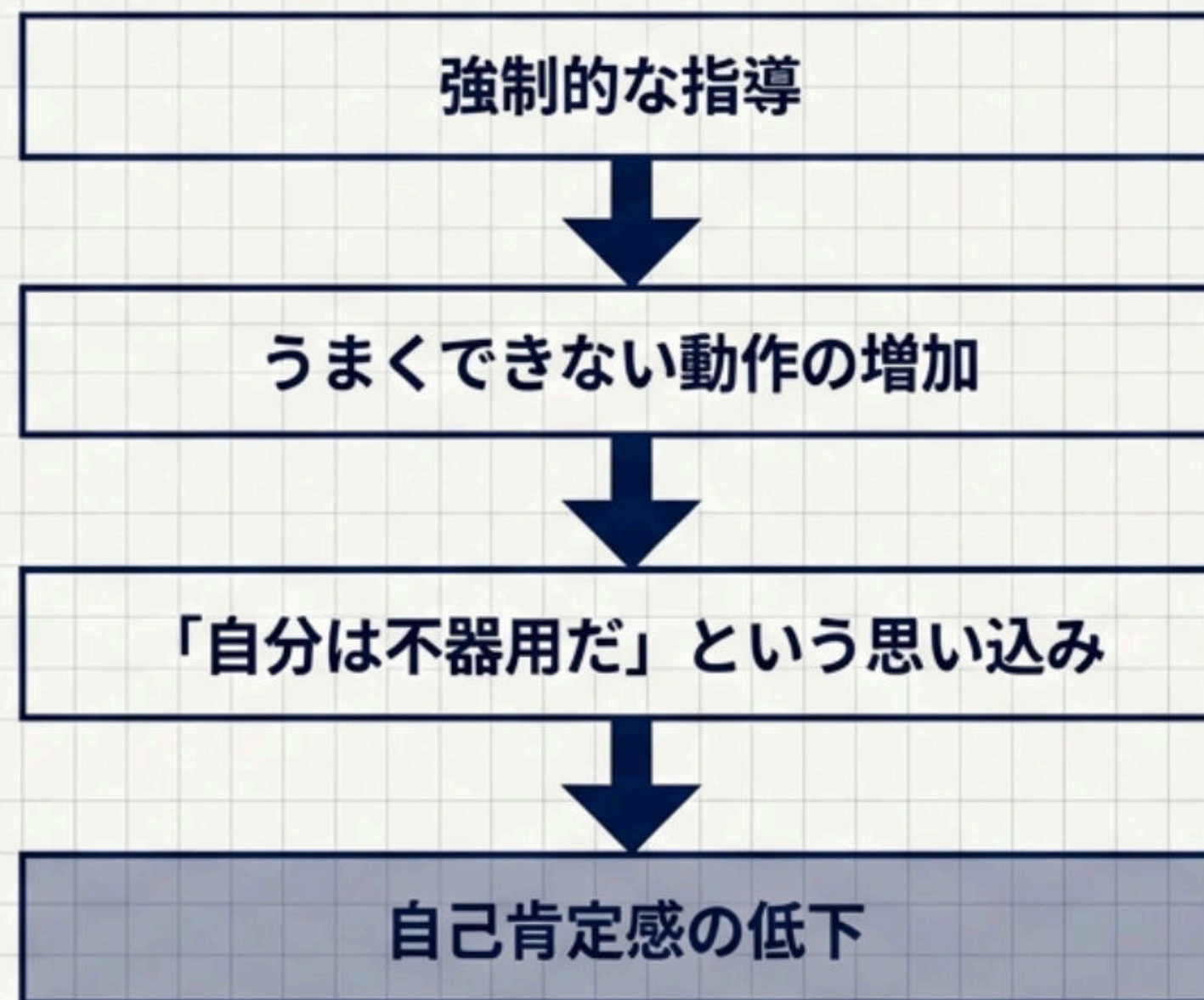
本来の自分らしさを犠牲にする「矯正」のリスク

かつては「左利き＝行儀が悪い」とされ、給食を取り上げられたり、右手を強制される時代がありました。

しかし、左手を使って感じる不便さよりも、本当は使いやすい手を封じられるストレスの方が、子どもの心に深い傷を残します。

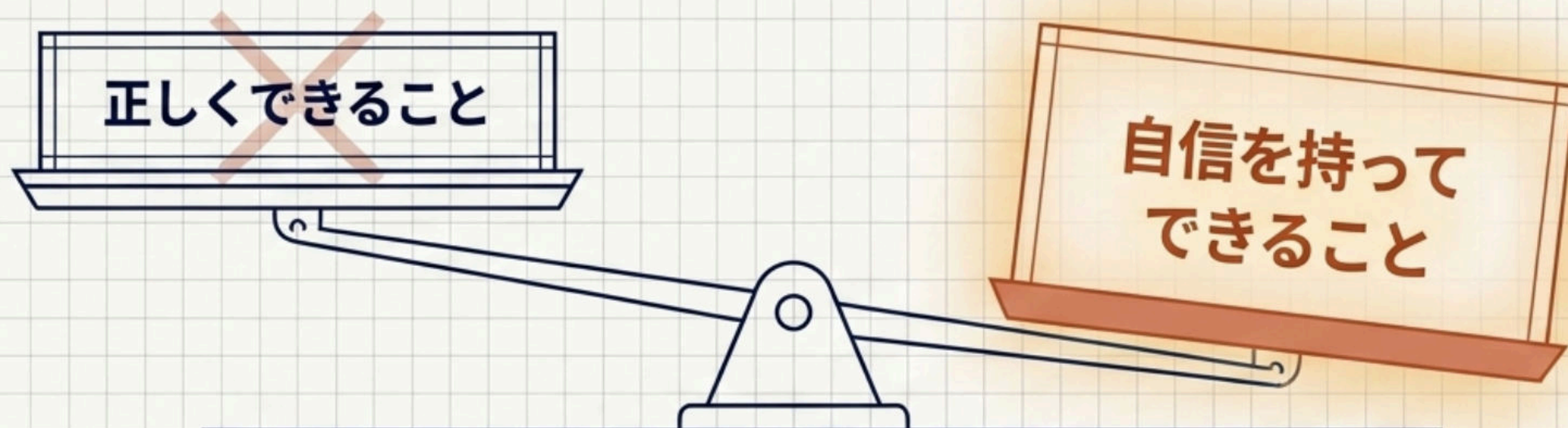
支援の出発点は、「間違いを正す」ことではありません。

無理な矯正がもたらす負のループ



支援の真の目的は「正しさ」ではなく「自信」

私たちが目指すのは、右利き用の社会に無理やり適応させることではなく、子どもが「自然体」でいられる環境を作ることです。



・観察する：得意・不得意、どちらの手を使っているかを見極める

・対話する：決めつけず、本人の感覚を尊重する

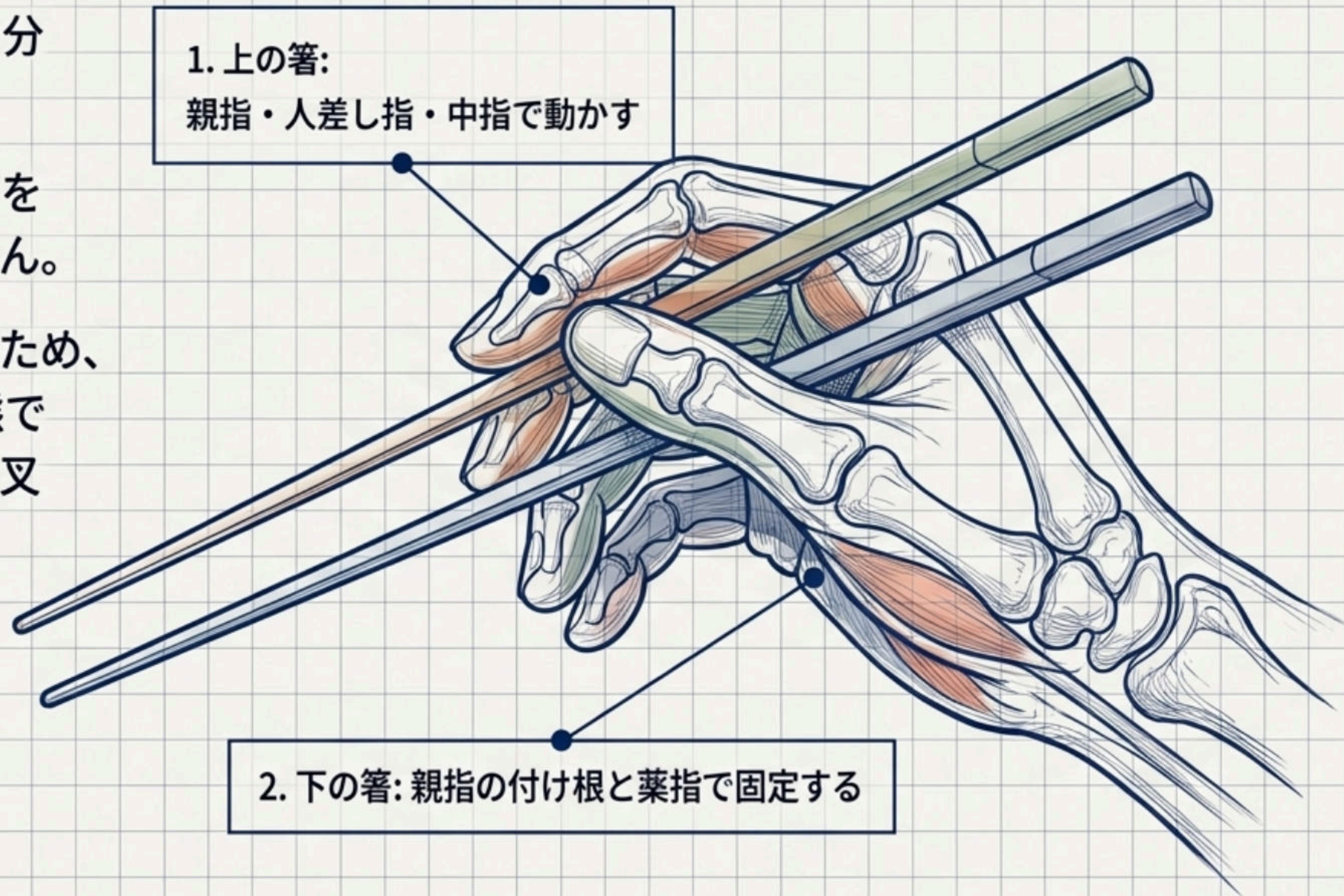
・道具を選ぶ：無理なく、必要なものから順番に用意する

なぜ「お箸」は難しいのか？（構造の理解）

箸の操作は、非常に高度な指の分離運動を要求します。

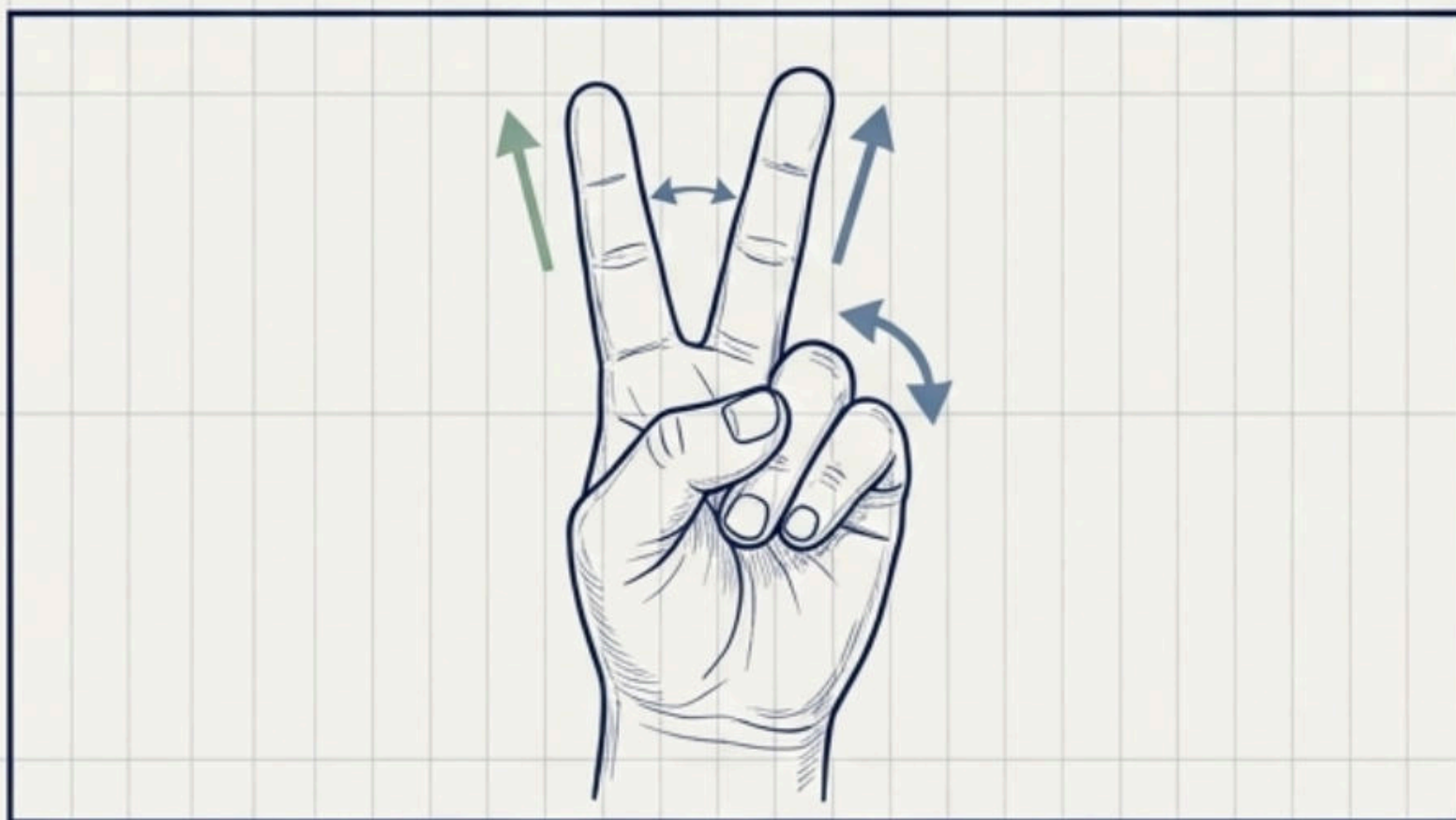
上の箸を動かしながら、下の箸を完全に固定しなければなりません。

各指が全く異なる役割を果たすため、手の機能発達が十分でない状態で無理に持たせると、握り箸や交叉箸の原因となります。

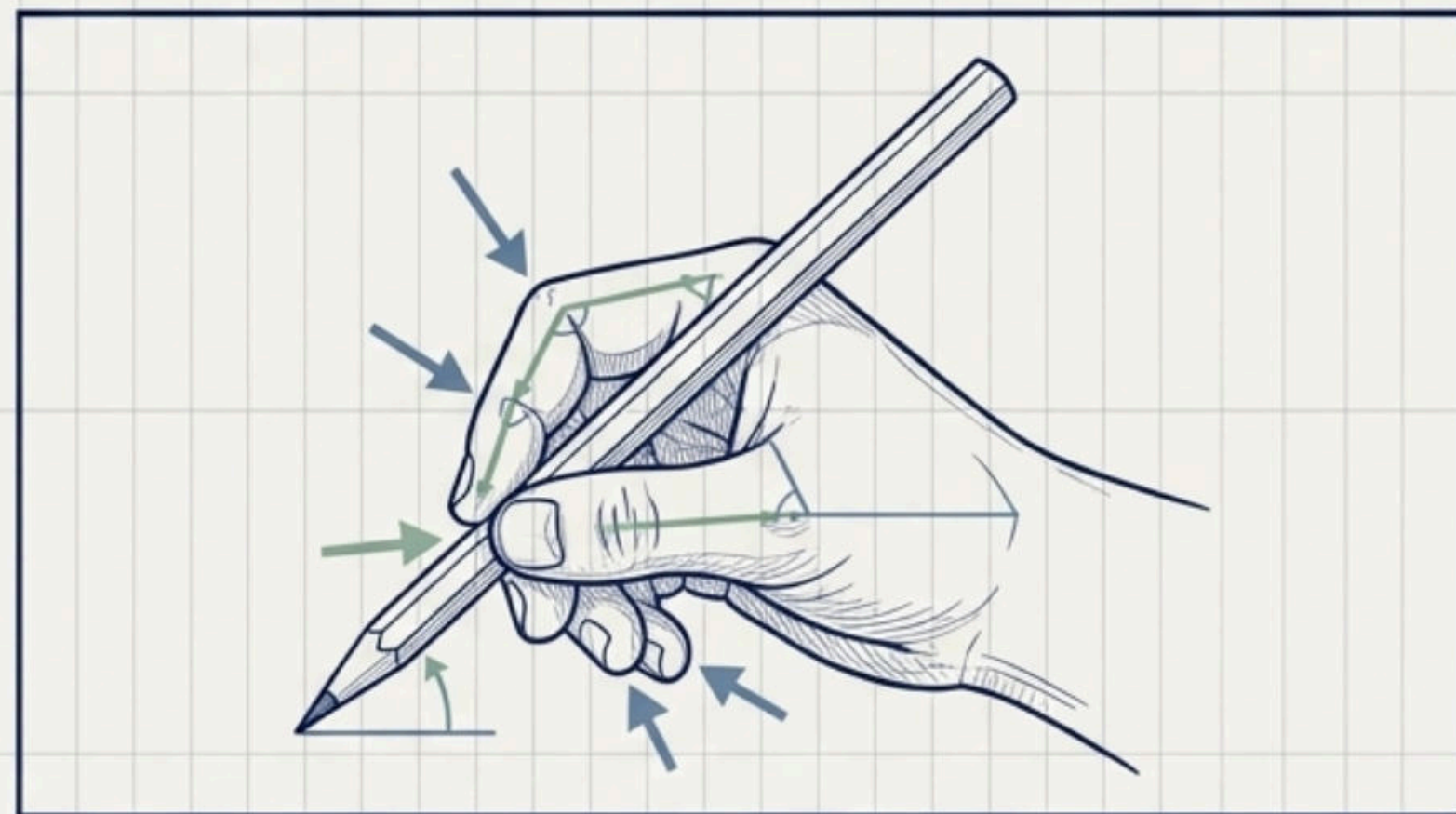


手の発達状態を見極める2つのチェックポイント

年齢（3～4歳）を基準にするのではなく、身体の準備ができているかを確認します。親指・人差し指・中指のグループと、薬指・小指のグループをバラバラに動かせる（分離運動）ことが、箸への移行の絶対条件です。これが難しい場合は、まず遊び（指折り計算、お絵かき）の中で基礎的な指の力を育てます。



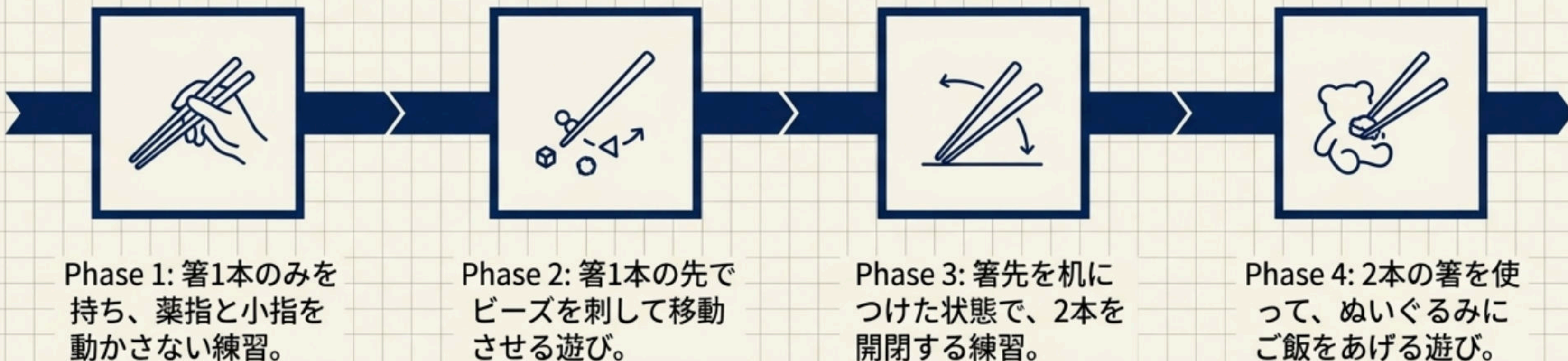
診断 1：「チョキができるか？」



診断 2：「3本指で色鉛筆を持てるか？」

スモールステップで進める導入プロセス

食事の場面でいきなり使わせると、失敗体験からお箸への苦手意識が強まります。
遊びを通じたスモールステップが効果的です。



補助具・トレーニングツールの比較と選択

	 リング付き補助箸	 特殊構造補助箸	 普通の箸
メリット	指の力が弱くてもすぐにつかめる。ストレスが少ない。	指が離れず、正しい筋肉の動きを学習できる。	最終目標。指先の力が根本から育つ。
デメリット	開く際にリングを利用するため、指が箸から離れる癖がつきやすい。	一般的な店舗では手に入りにくく、比較的高価。	初期のハードルが高く、挫折しやすい。
移行への課題	普通の箸に移行する際、結局一から教え直すことが多い。	スムーズな移行が期待できるが、外食時の携帯が必要。	(最終形態のため移行課題なし)

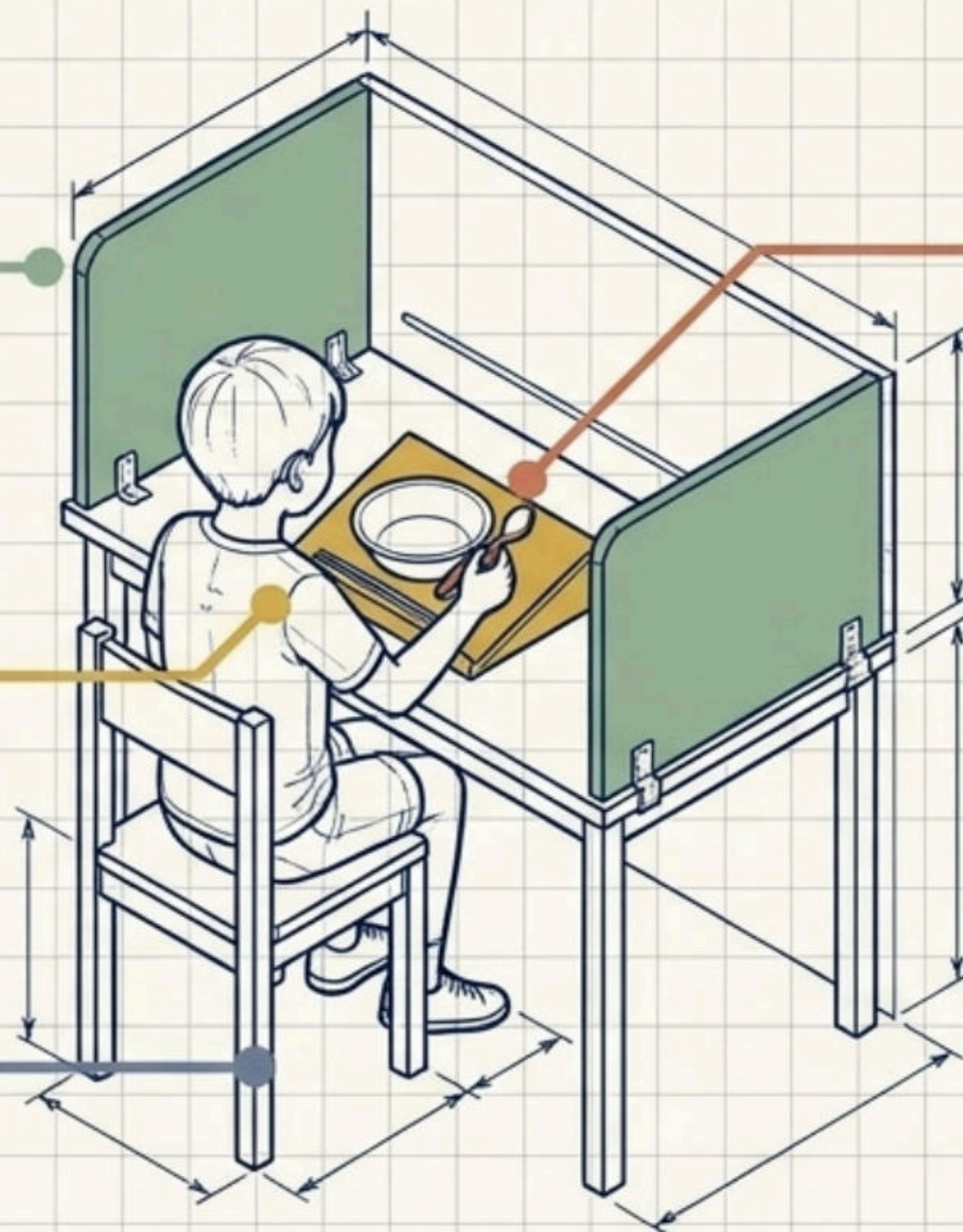
「360度」の食事環境デザイン

箸やスプーンの操作（手元）だけに注目してはいけません。姿勢の安定や、注意力のコントロールを含めた環境全体の調整が必要です。食器の傾斜を変えるだけで、すくう動作の連続性が劇的に向上します。

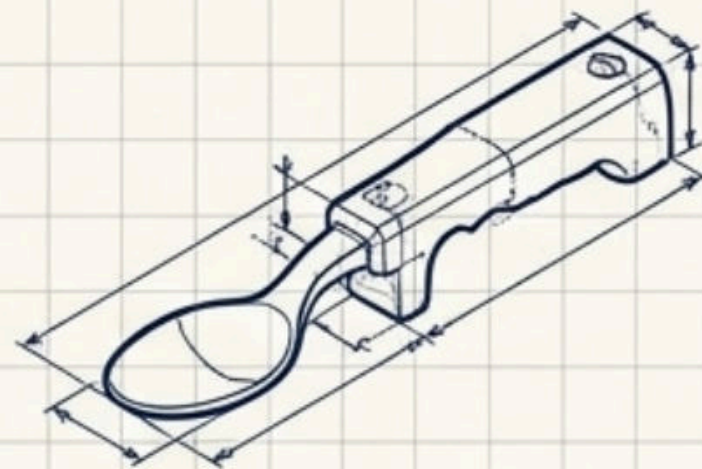
3. 視覚刺激の遮断:
注意の安定をも防らぐ

2. 傾斜台の導入:
単一動作でのすくいを
可能にする

1. 足裏の接地:
体幹の安定をもたらす



4. スプーンのカスタマイズ:
手首の角度を補正する
特殊グリップ



4. スプーンのカスタマイズ:
手首の角度を補正する
特殊グリップ

2024年法改正対応：5領域の理解

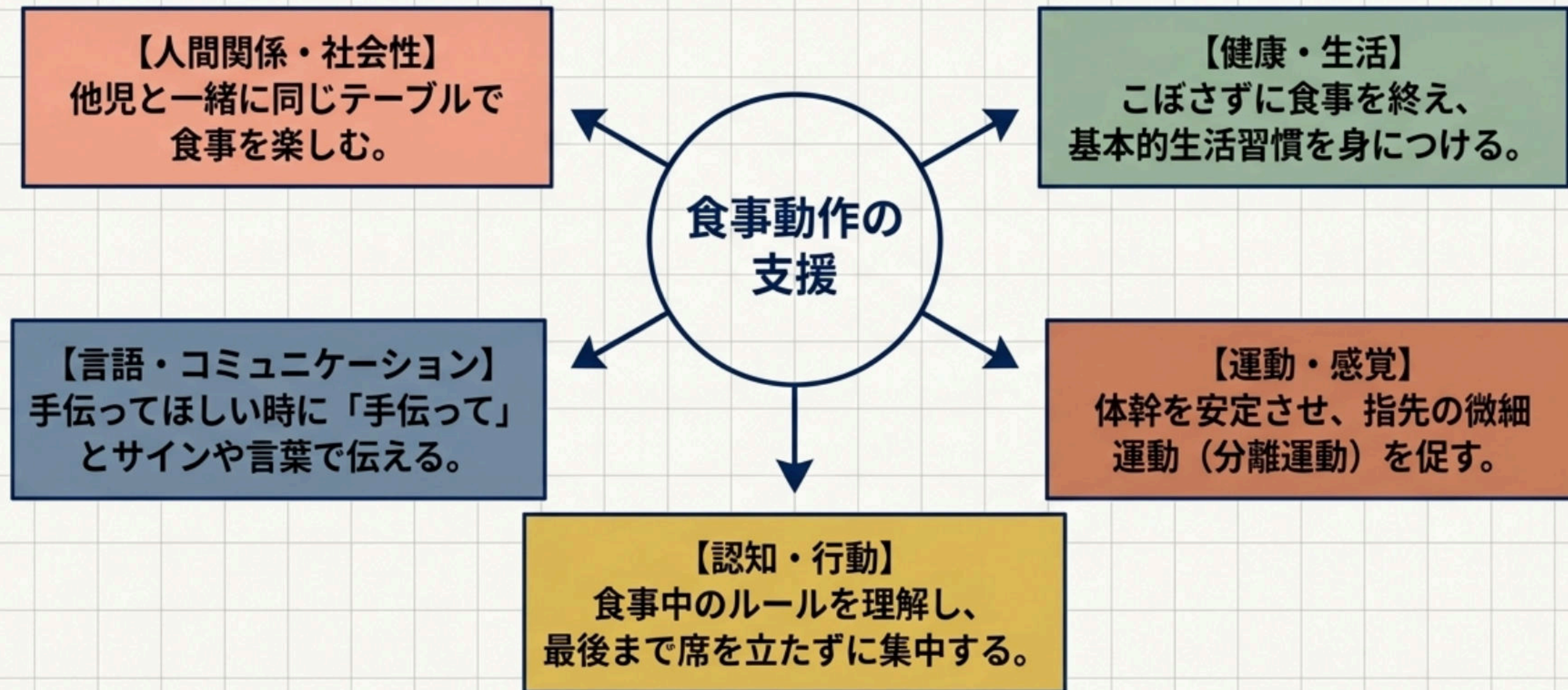
放課後等デイサービスや児童発達支援における個別支援計画は、これら5つの領域すべてを網羅して作成することが義務化された。

支援の現場で行われている日々の介入を、この5領域の言語に翻訳するスキルが求められます。



ひとつの支援行動を「5領域」に展開する

「お箸の練習」は、単なる手先の訓練ではなく、総合的な発達支援です。



個別支援計画書の最適化（NG→OK変換）

実地指導や加算取得に耐えうる計画書は、「具体性・根拠性・実行可能性」が必須です。

抽象的でNGな表現

「生活習慣を身につける」

「自立に向けた支援を行う」

「人と関わる力をつける」

具体的でOKな表現

【健康・生活】スプーンやエジソン箸を使い、こぼさずに15分間で食事を終える（週3回）。

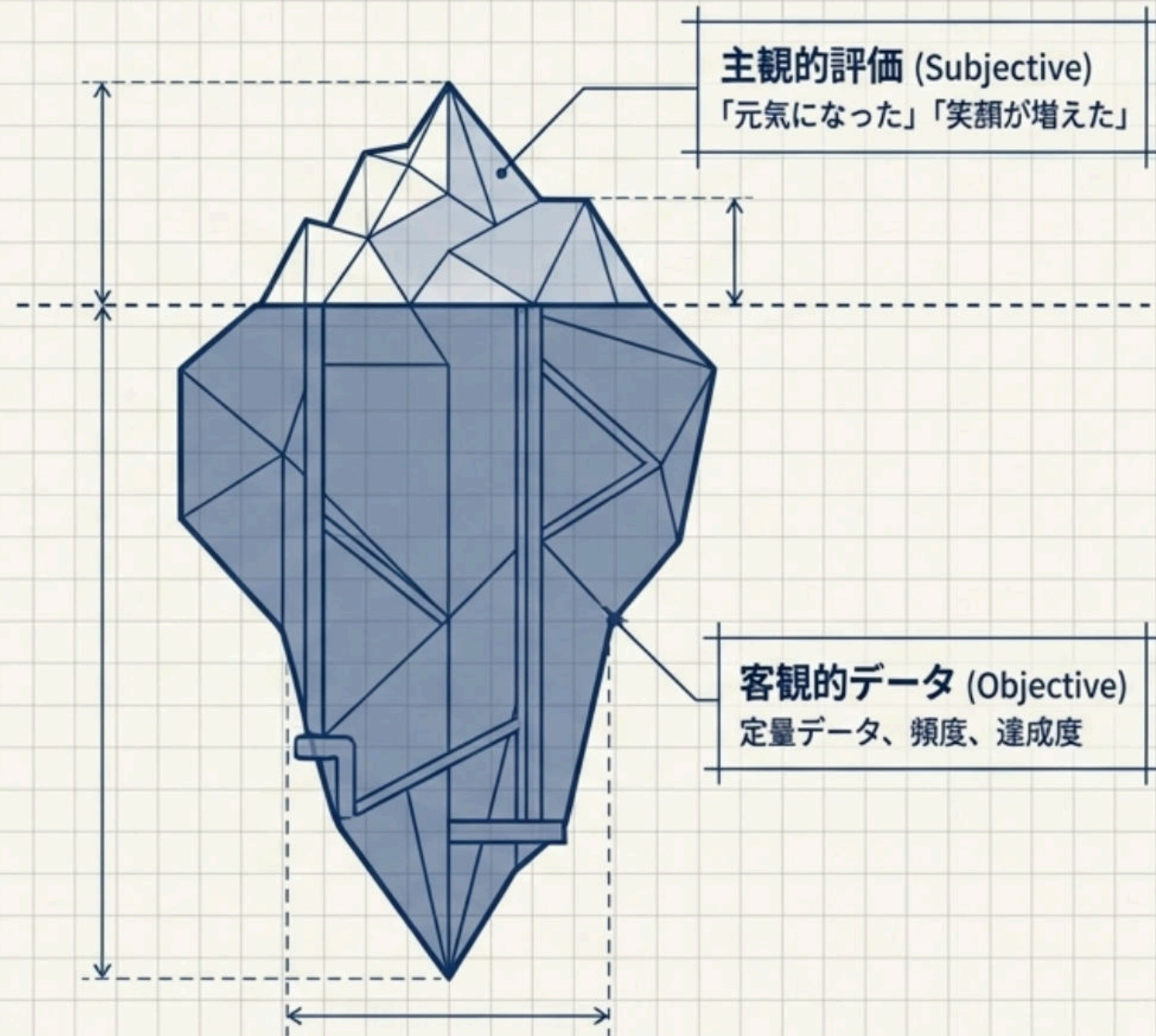
【運動・感覚】本人の握力に合わせた太柄のスプーンと傾斜台を用意し、単一動作ですくう環境を整える。

【人間関係】自由遊びの時間に、3人以上の子どもと5分以上関わる場면을月2回以上持つ。

なぜ「効果測定」が必須なのか？

多くの事業所が「笑顔が増えた」という定性的な評価にとどまっています。

しかし、行政への説明責任、保護者への説得力、そして何より「支援の質的改善」のためには、成長を客観的な数字で証明する「定量的な効果測定」の仕組みが不可欠です。

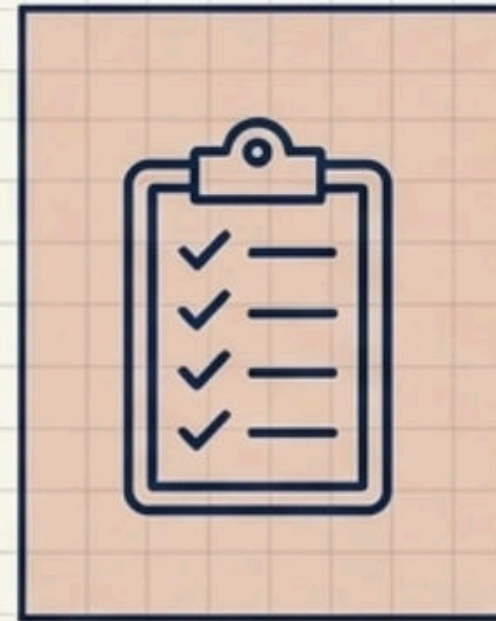


成長を可視化する4つの効果測定フレームワーク



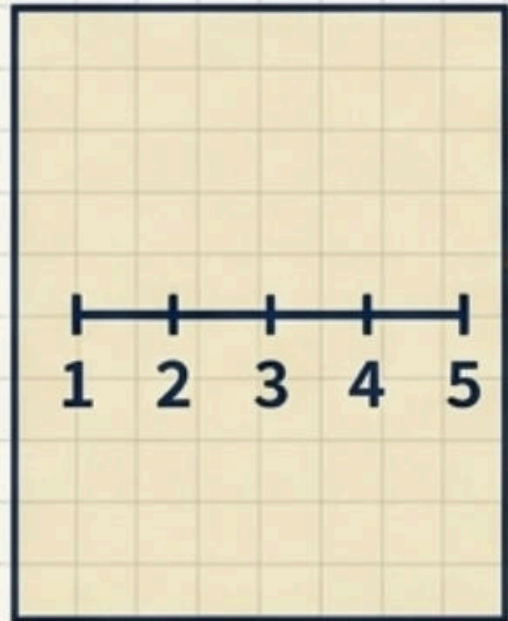
1. 行動の「頻度」測定

例「60分の支援中に、自分から話しかけた回数（月間5回→15回）」



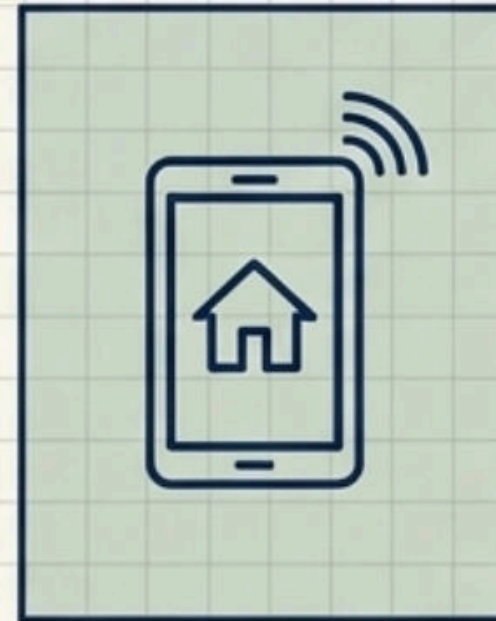
2. 「達成度」チェックリスト

発達段階を細分化し（例：指名で返事→単語で回答→複文で表現）、月1回チェック。



3. 5段階評価スケール

1（全くできない）から5（複雑な指示も理解できる）まで、毎月の推移を追跡。

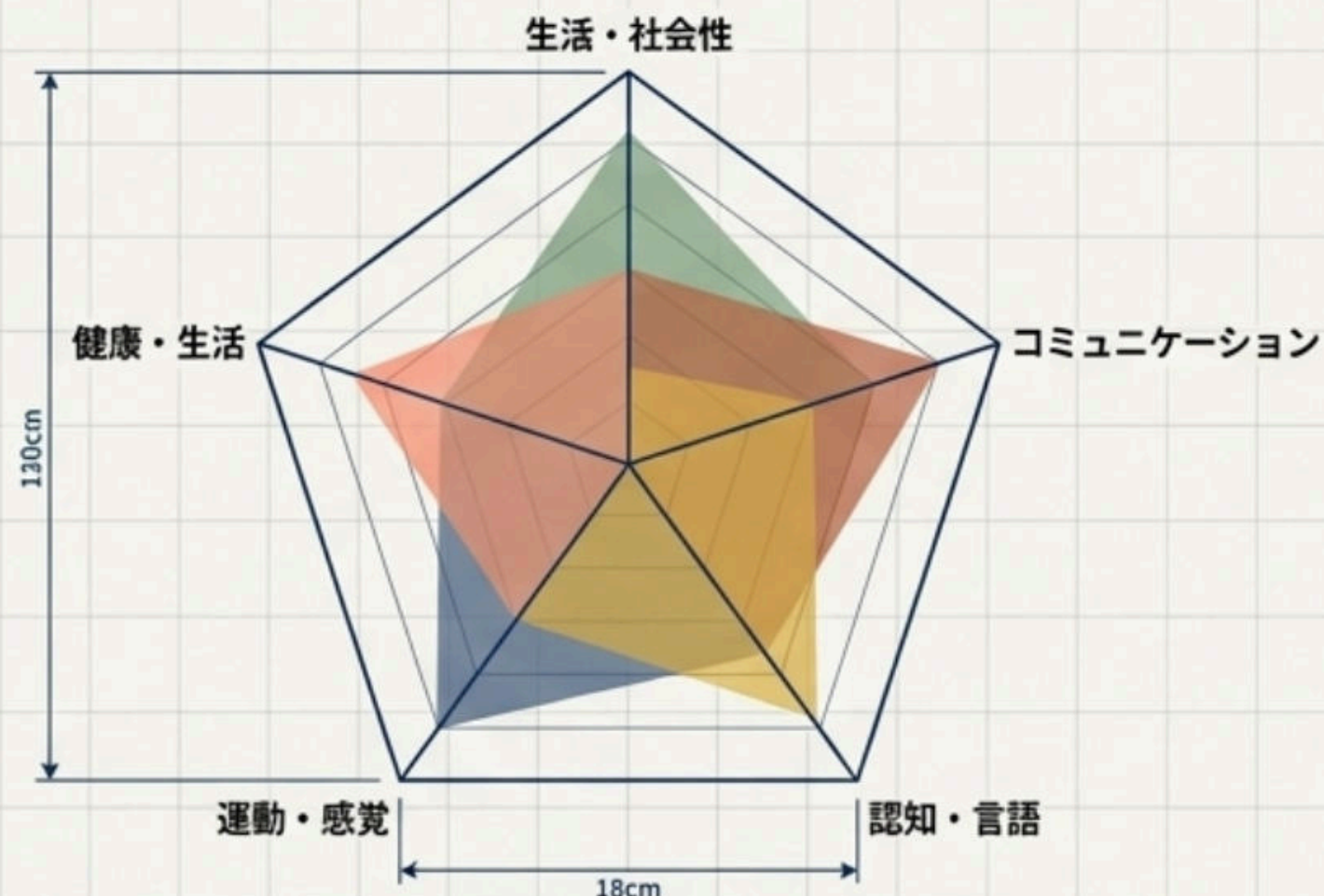
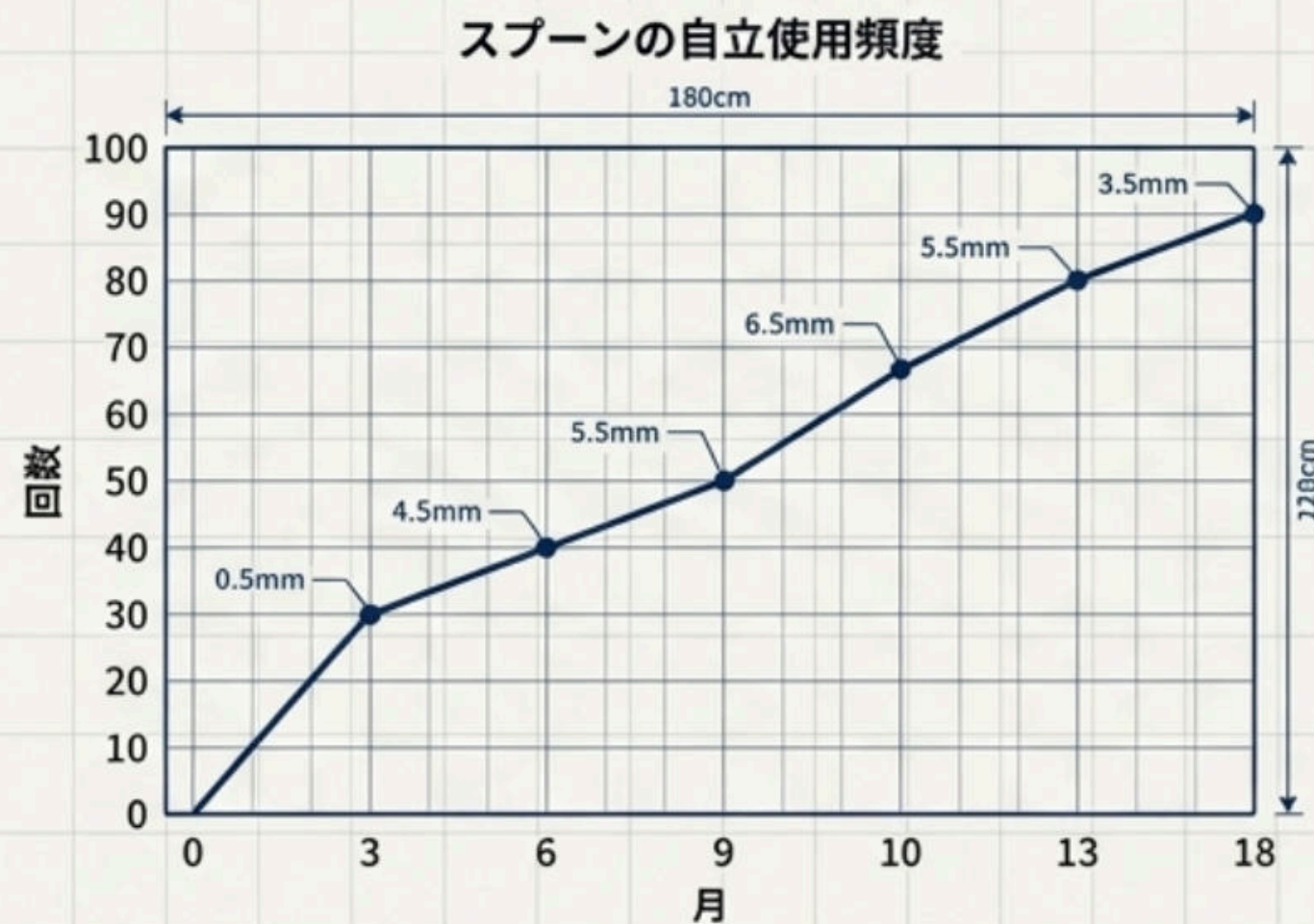


4. 保護者評価・ICT連携

連絡帳アプリを活用し、「家庭でも変化を感じるか」を5段階で取得。

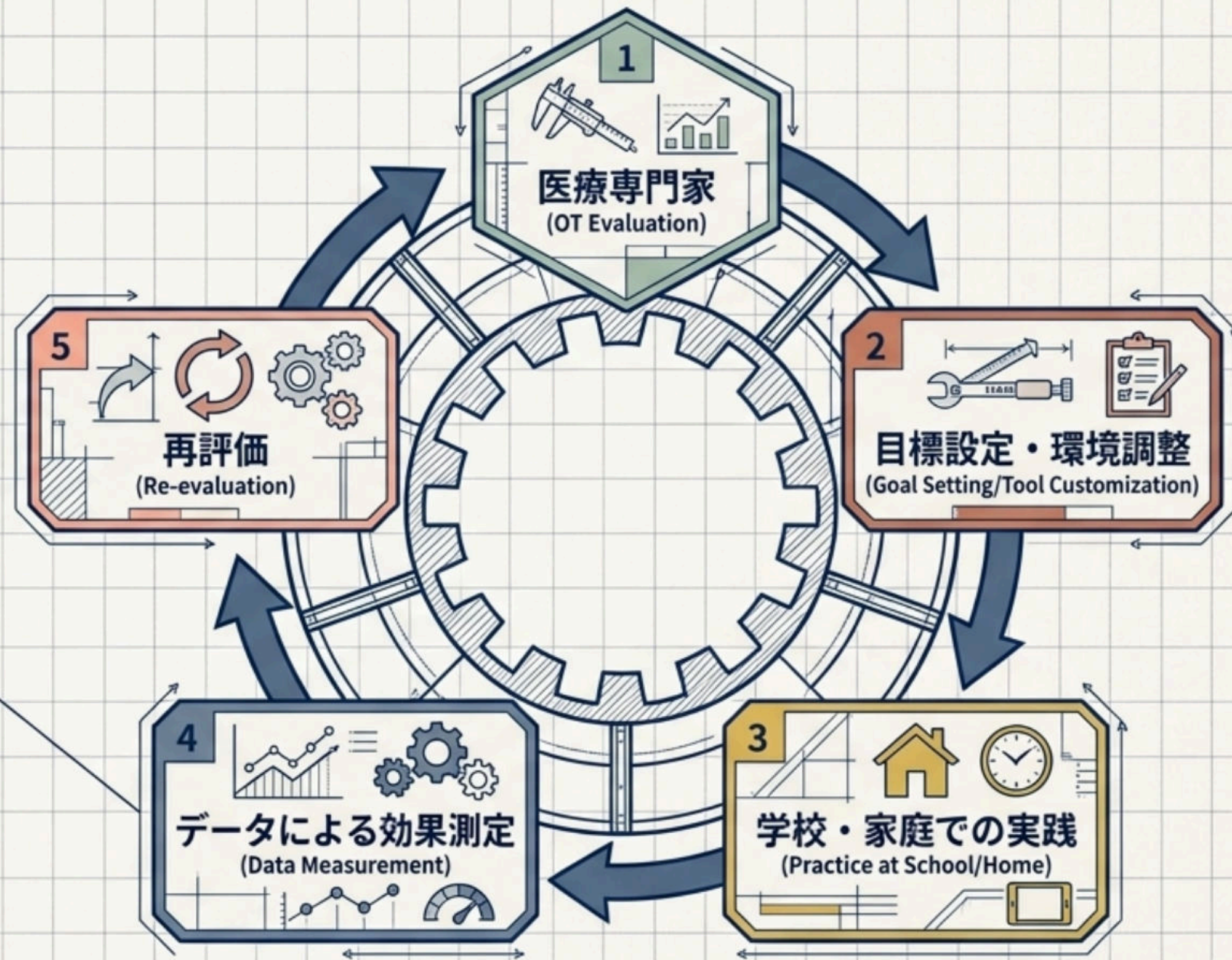
データが証明する「成長の軌跡」

日々の支援記録（例：「今日のコミュニケーション回数は8回」）を蓄積することで、グラフによる自動測定が可能になります。このデータを月1回の振り返り会で分析し、「スタッフAの支援時に成長が早いのはなぜか？」「落ち着きが改善しないのは運動不足か？」といった仮説立案に繋がります。



専門家連携によるPDCAサイクルの構築

支援は一度計画を立てて終わりではありません。重度・重複障害児の支援では、乳幼児期から関わる作業療法士（OT）と教員が情報提供書を通じてコンサルテーションを行い、蓄積された測定データに基づいて、自助具の角度や声かけのタイミングを継続的にアップデートしていく体制が必要です。



効果測定の本質は「成長を愛する」こと

緻密な個別支援計画も、厳密なデータ測定も、単なる行政対応の事務作業ではありません。数字の向こう側にある「この子はこんなにできるようになった」という感動を発見するための仕組みです。深い共感と冷徹なデータ分析の交差点にこそ、子どもが真に「自分らしく、自信を持って生きる」ための支援が存在します。

